

Hematuria

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Libro negro de Nefrología de la SAP 2008

AEP 2014

Las infecciones urinarias, los traumatismos y la hipercalcemia son las causas principales de hematuria. La nefropatía IgA constituye la causa más frecuente de hematuria glomerular (habitualmente como hematuria macroscópica recidivante). Las infecciones urinarias y la hipercalcemia idiopática son la causa más frecuente de hematuria extraglomerular. Se debe realizar cribado familiar de hematuria en todos los casos de microhematuria persistente.

Etiologías

- 1- Glomerulopatías
 - Glomerulonefritis aguda postestreptocócica ***
 - Glomerulonefritis aguda posinfecciosa (neumococo, estafilococo, virus, etc)**
 - Síndrome nefrótico primario**
 - Nefritis con depósitos mesangiales de IgA (Enfermedad de Berger)**
 - Glomerulonefritis membranoproliferativa*
- 2- Enfermedades sistémicas con afectación glomerular
 - SUH***
 - Púrpura de Schönlein-Henoch***
 - Lupus eritematoso sistémico*
 - Vasculitis*
- 3- Trastornos renales hereditarios
 - Enfermedad renal poliquística**
 - Nefritis hereditaria con hipoacusia (Alport)*
 - Enfermedad de la membrana basal delgado (hematuria familiar benigna)*
- 4- Enfermedad del tracto urinario
 - ITU***
 - Traumatismos***
 - Uropatías obstructivas (obstrucción urétero-piélica, megauréter obstructivo, etc.)
 - Litiasis*
- 5- Misceláneas
 - Ejercicio intenso prolongado**
 - Infección respiratoria o gastrointestinales (transitoria)**
 - Hipercalcemia**
 - Trastornos hemorrágicos **
 - Administración de citostáticos (ciclofosfamida, cisplatino, etc)**
 - Hipoxia (especialmente recién nacidos)**
 - Hipersensibilidad a fármacos (penicilinas, sulfas, etc.)

Frecuente*** - Relativamente frecuentes** - Poco frecuente*

Hematuria persistente: se define como aquella hematuria que se encuentra seis meses después de la primera determinación.

Hematuria transitoria: cuando se observa en una muestra aislada o en un tiempo inferior a seis meses.

Anamnesis

- Color de la orina
- Hematuria inicial, total o terminal
- Antecedentes de Tx
- Presencia de coágulos
- Duración del episodio
- Antecedentes de cuadro similar
- Síntomas asociados:
 - Disuria
 - Cólicos/lumbalgia
 - Cuadros respiratorios
- Antecedentes familiares:
 - Insuficiencia renal
 - Diálisis
 - Litiasis
 - Quistes renales
 - Hipoacusia

Examen físico

- Temperatura
- TA
- Edemas
- Exantema
- Artralgias
- Oliguria

Orientación diagnóstica

Variable	Glomerular	Tracto urinario
Color	Color oscuro (de pardo verdoso a achocolatado), como Coca-Cola	Rosada o rojiza
Refuerzo inicial	Ausente	Ocasionalmente en las enfermedades del tracto urinario inferior
Relación con micción	Se encuentra presente durante toda la micción	No uniforme. En ocasiones, durante toda la micción (más intensa al inicio)
Coágulos	Ausentes	Ocasionalmente
Cilindros hemáticos	Presente en el 30 – 50% de estas hematuria (alta especificidad)	Ausente
Dismorfia eritrocitaria	Muy frecuente (en general > del 20-30% de los eritrocitos evaluados)	Ausente
Acantocitos	Presentes (más del 5% alta especificidad)	Ausentes
Proteinuria	Fr: >100mg/dl o ++ en única muestra (poco valorable en hematuria macroscópica ya que las proteínas son de los hematíes hemolisados) o >500 mg/día en orina de 24hs y en los casos que no hay control de esfínteres o no se recolecta la orina en 24hs: índice proteinuria/creatinuria (mg/mg) >0.2 (>de 2a > 0.5)	Ausente o no más de 100mg/dl (+): relacionada con la presencia de proteínas plasmáticas

Cuando la sospecha inicial sea de causa glomerular indicar dieta hiposódica.

